HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP CITRA TUBUH DENGAN PERILAKU MAKAN PADA REMAJA

Proposal Penelitian

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Strata Sarjana (S1)
Program Studi Sarjana Keperawatan

Oleh:

Terezah Devi Sinta
K1A2 23 010

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Tubuh dengan Perilaku Makan pada Remaja di Kota Kendari
Nama	:	Terezah Devi Sinta
NIM	:	K1A2 23 010
Program Studi	:	Sarjana Keperawatan
Fakultas	:	Kedokteran

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Sukurni, S.Kep., Ns., M.Kep	**La Rangki, S.Kep., M.Kep**
NIP: 19780124 199803 2 002	**NIP: 19790705 200502 1 010**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Keperawatan FK UHO

Saida, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIP: 1981082 2005022 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Perilaku Makan 10

B. Tinjauan Umum Remaja 18

C. Tinjauan Umum Citra Tubuh 21

D. Hubungan antara Citra Tubuh dengan Perilaku Makan pada Remaja 30

E. Kerangka Teori 32

F. Kerangka Konsep 33

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Rancangan Penelitian 34

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 34

C. Populasi dan Sampel Penelitian 34

D. Teknik Pengumpulan Data / Prosedur Penelitian 37

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 39

F. Teknik Analisa Data 41

G. Alur Penelitian 43

H. Etika Penelitian 44

DAFTAR PUSTAKA 47

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Teori	32
Gambar 2	Kerangka Konsep	33
Gambar 3	Alur Penelitian	44

DAFTAR LAMPIRAN

NomorLampiran	Nama Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Menjadi Responden	54
Lampiran 2	*Informed Consent*	55
Lampiran 3	Data Demografi Responden	56
Lampiran 4	Kuesioner Citra Tubuh	57
Lampiran 5	Kuesioner Perilaku Makan	59

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang dan Singkatan	**Arti**
.	Titik
,	Koma
<	Kurang dari
>	Lebih dari
≤	Kurang dari atau sama dengan
≥	Lebih dari atau sama dengan
-	Sampai dengan
( )	Dalam kurung
%	Persen
AKG	Angka Kecukupan Gizi
AFHC	*Adolescent Food Habit Checklist*
EAT-26	*The Eating Attitude Test*
DEBQ	*Dutch Eating Behavior Questionnaire*
BSQ	*Body Shape Questionnaire*
WHO	*World Health Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah fase kehidupan antara masa kanak-kanak hingga dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. Ini adalah tahap unik dalam perkembangan manusia dan waktu penting untuk meletakkan dasar kesehatan yang baik. Remaja mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial yang cepat. Hal ini memengaruhi bagaimana mereka merasa, berpikir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka (WHO, 2026). Selain itu perubahan gaya hidup saat ini sangat berpengaruh terhadap status gizi dari remaja. Perubahan fisik pada remaja juga dapat memberikan dampak psikologis, dimana remaja akan lebih memperhatikan bentuk tubuh untuk menyesuaikan ideal tubuh mereka, terutama pada remaja putri, sehingga akan ada kecenderungan untuk membatasi asupan makanan agar berat badan tidak berlebih. Pada umumnya remaja putri biasanya menginginkan bentuk tubuh yang langsing, tinggi, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan gizi ataupun nutrisi yang masuk dalam tubuh untuk kesehatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Hamaliyah (2023) menyoroti bahwa pentingnya citra tubuh seorang remaja dalam memengaruhi status gizi mereka. Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh remaja seringkali membuat mereka melakukan diet yang ketat dan tidak sehat sehingga berdampak negatif terhadap status gizi remaja. Tekanan

dari sosial, lingkungan pertemanan dan juga maraknya tren kecantikan akan mempengaruhi cara remaja menilai tubuhnya sendiri.

Gizi kurang akibat mengejar *body goal* dengan diet yang tidak tepat. Persepsi mengenai tubuhnya akan dinamis seiring dengan lingkungan yang ia rasakan (Niswah I, Rah JH, Roshita A., 2021) . Hal ini dapat memicu para remaja untuk memodifikasi makanan maupun waktu makan yang tidak tepat, mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak seimbang untuk mendapatkan bentuk badan yang diinginkan dan juga menunda-nunda makan karena badan yang sudah terlihat gemuk kelebihan asupan gizi yang dapat menyebabkan obesitas.

Remaja putri yang melakukan diet ketat biasanya menyebabkan remaja kurang mendapatkan makanan seimbang dan bergizi, mengkonsumsi obat pelangsing, minum jamu dan sebagainya. Upaya tersebut dapat berakibat pada penurunan status gizi bila tidak melakukan diet dengan benar dimana asupan energi dan zat gizi kurang dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang sudah dianjurkan.Status gizi remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi remaja adalah *body image* (Savitri., Arini & Ilmi., 2023). Citra tubuh dapat terjadi pada remaja pasca pubertas karena akibat perubahan bentuk dan berat badannya sehingga menyebabkan remaja tidak puas dengan postur tubuh yang dimiliki meskipun normal atau bahkan kekurangan berat badan (Jakutowicz, 2023). Kontribusi status Gizi yang baik sangat penting bagi remaja

adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja, termasuk kesehatan tulang dan gigi. Masalah gizi yang masih banyak ditemukan pada kelompok remaja meliputi kekurangan gizi dan gizi lebih/obesitas (Kemenkes, 2023).

Permasalahan gizi pada remaja tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan masalah kesehatan yang terjadi secara global. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2022 sekitar 20% anak dan remaja usia 15–19 tahun di dunia mengalami overweight, termasuk sekitar 8% yang mengalami obesitas. Pada kelompok usia yang sama, sekitar 9,6% masih mengalami kondisi kurus *(thinness*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi pada anak dan remaja masih menghadapi beban ganda, yaitu meningkatnya masalah kelebihan berat badan dan obesitas, sementara masalah kekurangan gizi masih terjadi pada sebagian besar populasi remaja di dunia (WHO, 2025).

Di Indonesia, situasi ini juga tercermin dalam hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pada kelompok usia 13–15 tahun terdapat peningkatan prevalensi remaja dengan berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,2%, sementara 7,6% remaja masih mengalami status gizi kurang. Data tingkat provinsi juga menunjukkan masalah yang serupa. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 9,6% remaja usia 13–15 tahun mengalami gizi kurang, sedangkan

11,9% mengalami gizi lebih dan obesitas. Di Kota Kendari, data Dinas Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa hasil penjaringan kesehatan pada peserta didik terdapat 49 siswa mengalami stunting, 361 siswa mengalami status gizi kurang, dan 392 siswa mengalami status gizi lebih dan obesitas. Pemilihan SMAN 2 Kendari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil pengamatan awal peneliti dan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah. Berdasarkan pengamatan awal serta keterangan dari guru dan petugas keamanan sekolah, diketahui bahwa terdapat keberagaman karakteristik fisik siswa, seperti adanya siswa dengan tubuh yang relatif kurus maupun lebih berisi. Keberagaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam memilih SMAN 2 Kendari sebagai lokasi penelitian, karena kondisi fisik yang beragam dapat menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan bagaimana remaja mempersepsikan gambaran tubuhnya. Namun, kondisi fisik yang terlihat secara langsung belum dapat menggambarkan persepsi siswa terhadap tubuhnya maupun perilaku makannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap gambaran tubuh dengan perilaku makan pada remaja di SMAN 2 Kendari. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah status gizi pada remaja sekolah masih memerlukan perhatian khusus karena terjadi baik pada kategori gizi kurang maupun gizi lebih. Permasalahan ini semakin kompleks karena masalah gizi remaja tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan semata, tetapi juga

berkaitan dengan faktor psikologis seperti persepsi terhadap citra tubuh. Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dapat memicu remaja mengubah kebiasaan makan secara tidak sehat, baik dengan membatasi makan secara ekstrem maupun makan berlebihan sebagai respons emosional. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan zat gizi yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, konsentrasi belajar, dan kondisi psikososial remaja.

Penelitian mengenai hubungan antara citra tubuh dengan perilaku makan remaja dapat menunjukkan adanya hubungan terhadap remaja dalam mengevaluasi dirinya. Penelitian Lionita dkk. (2022) pada 138 remaja putri di sekolah menengah atas palembang mempunyai hubungan yang signifikan terkait persepsi citra tubuh dengan perilaku makan. Remaja dengan citra tubuh positif memiliki kemubgkinan lebih besar untuk memiliki perilaku makan yang baik dibandingkan remaja yang memiliki citra tubuh negatif. Hasil ini menunjukkan citra tubuh dengan perilaku makan remaja saling beterkaitan. (Lionita dkk., 2022).

Hasil penelitian Wangu dkk. (2023) menunjukkan bahwa 54% responden memiliki citra tubuh positif, sedangkan 56 responden berada pada posisi beresiko mengalami gangguan perilaku makan. Temuan tersebut menujukkan bahwa adanya permasalahan yang timbul terhadap persepsi remaja dapat mengakibatkan gangguan perilaku makan yang beresiko. (Wangu dkk., 2023)

Persepsi terhadap citra tubuh dapat berkaitan dengan perilaku

makan remaja untuk mendapatkan tubuh yang dianggap ideal, remaja yang merasa bentuk tubuhnya tidak ideal akan berusaha melakukan upaya untuk mengubah bentuk tubuhnya, termasuk mengatur atau membatasi konsumsi makanan. Penelitian Wassalwa dan Khomsan (2023) menujukkan bahwa intensitas penggunaan instagram berkaitan dengan body *dissatisfaction*, perilaku makan, dan status gizi pada remaja. Paparan terhadap gambaran tubuh ideal di media sosial dapat membuat remaja membandingkan bentuk tubuhnya sendiri dan meningkatkan ketidakpuasaan sehingga memengaruhi perilaku yang berkaitan dengan makanan. Wassalwa dan Khomsan (2023).

Perilaku makan pada remaja merupakan perilaku yang kompleks karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan lingkungan. Rachmi dkk. (2021) melalui tinjauan sistematis mengenai perilaku makan remaja Indonesia menunjukkan bahwa perilaku makan remaja berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain konsumsi makanan, kebiasaan sarapan, konsumsi makanan ringan, makanan cepat saji, serta konsumsi buah dan sayur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa remaja dapat memiliki pola makan yang beragam dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan gizi selama masa pertumbuhan. Oleh karena itu, perilaku makan pada masa remaja perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. (Rachmi dkk., 2021).

Permasalahan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas

akademik remaja secara tidak langsung. Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya dapat memnimbulkan tekanan psikologis dan membuat remaja lebih banyak memusatkan perhatiaannya pada bentuk tubuhnya. Sementara itu perilaku makan yang tidak sehat terutama pembatasan makanan dapat membuat pemenuhan gizi pada remaja itu tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi psikologis dan fisik tersebut dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan energi, serta mengganggu kemampuan remaja untuk mempertahankan konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. (Rachmi dkk., 2021; Wangu dkk., 2023).

Pada masa remaja, kemampuan untuk berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran membutuhkan kondisi fisik dan psikologis yang baik, pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi yang tidak optimal dapat memengaruhi kondisi fisik remaja, sedangkan tekanan psikologis akibat ketidakpuasan terhadap tubuh dapat mengganggu kesejahteraan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, citra tubuh dan perilaku makan perlu diperhatikan dalam upaya mendukung kesehatan remaja secara menyeluruh, termasuk kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas pendidikan di sekolah. (Rachmi et al., 2021; Wassalwa & Khomsan, 2023).

Melihat fenomena tersebut, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana persepsi terhadap citra tubuh memengaruhi perilaku makan remaja, terutama pada remaja sekolah yang berada pada masa

kritis perkembangan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti edukasi gizi, konseling Citra tubuh positif, dan penguatan program promotif serta preventif di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Hubungan antara Persepsi terhadap Citra Tubuh dengan Perilaku Makan pada Remaja di Kota Kendari.

B. Perumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Tubuh Dengan Perilaku Makan pada Remaja di Kota Kendari

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

   Mengetahui hubungan antara persepsi remaja terhadap Citra Tubuh dengan perilaku makannya

2. Tujuan Khusus:

   a. Mengetahui bagaimana persepsi terhadap citra tubuh remaja di Kota Kendari
   b. Mengetahui bagaimana perilaku makan remaja di Kota Kendari
   c. Mengetahui bagaimana persepsi citra tubuh terhadap perilaku makan remaja

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

   Menambah wawasan ilmiah tentang hubungan persepsi citra tubuh dan perilaku makan remaja, serta menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan remaja dan keperawatan komunitas.

2. Manfaat aplikatif

   a. Bagi institusi

      Memberikan informasi dan masukan untuk tenaga kesahatan, guru BK, maupun orang tua agar meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait pentingnya citra tubuh yang positif serta perilaku yang sehat pada remaja.

   b. Bagi Masyarakat

      Bahan pertimbangan bagi pihak sekolah, dinas Pendidikan dan tenaga Kesehatan agar membuat kebijakan atau program kesehatan yang berfokus pada promosi kesehatan terkait pembentukan citra tubuh yang sehat dan pencegahan gangguan makan terhadap remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perilaku Makan

1. Definisi

Perilaku makan merupakan serangkaian tindakan individu yang berkaitan dengan cara memilih, mengonsumsi, dan merespons makanan. Perilaku tersebut tidak hanya mencakup jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga meliputi kebiasaan makan, preferensi terhadap makanan, serta pola konsumsi yang dilakukan secara berulang. Pada remaja, perilaku makan dapat terlihat melalui berbagai aspek, seperti kebiasaan sarapan, konsumsi makanan ringan, minuman, buah dan sayur, serta makanan cepat saji (Rachmi et al., 2021). Selain itu, perilaku makan remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan makanan di sekitarnya, termasuk ketersediaan, harga, dan kemudahan akses terhadap makanan yang dapat memengaruhi pilihan serta kebiasaan makan remaja (Shaw et al., 2023).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, perilaku makan pada remaja dapat dipahami sebagai pola dan kecenderungan individu dalam merespons, memilih, serta mengonsumsi makanan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional, upaya pengendalian asupan makanan, maupun rangsangan yang berasal dari lingkungan. Dalam penelitian ini, perilaku

makan mengacu pada tiga aspek yang terdapat dalam *Dutch Eating Behavior Questionnaire* (DEBQ), yaitu *emotional eating*, *restrained eating*, dan *external eating*. Ketiga aspek tersebut menggambarkan kecenderungan individu dalam merespons keadaan emosional, mengendalikan konsumsi makanan, serta merespons rangsangan makanan dari lingkungan. Ketiga dimensi tersebut merupakan bagian dari DEBQ yang dikembangkan untuk mengukur perilaku makan. Penggunaan DEBQ juga telah dibahas dalam penelitian mengenai perilaku makan dan asupan makanan pada anak dan remaja (van Strien et al., 1986; Maneschy et al., 2024).

a. Emotional Eating

Emotional eating merupakan kecenderungan individu untuk mengonsumsi makanan sebagai respons terhadap kondisi emosional, terutama emosi negatif. Individu dengan kecenderungan ini dapat terdorong untuk makan ketika mengalami perasaan seperti sedih, cemas, kecewa, atau kesepian, meskipun dorongan tersebut tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan fisiologis berupa rasa lapar. Dalam DEBQ, aspek *emotional eating* digunakan untuk mengukur kecenderungan makan yang berkaitan dengan keadaan emosional (van Strien et al., 1986). Pada anak dan remaja, perilaku makan juga perlu dikaji dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan pola konsumsi makanan yang berkembang selama masa pertumbuhan (Maneschy et al., 2024).

b. Restrained Eating

Restrained eating merupakan kecenderungan individu untuk secara sadar membatasi atau mengendalikan jumlah maupun jenis makanan yang dikonsumsi. Perilaku ini dapat berupa upaya mengurangi porsi makan, membatasi konsumsi makanan tertentu, atau mengontrol asupan makanan dengan tujuan tertentu, termasuk mengendalikan berat badan. Dalam DEBQ, *restrained eating* merupakan salah satu dimensi untuk mengukur kecenderungan individu dalam membatasi konsumsi makanan (van Strien et al., 1986). Penelitian mengenai perilaku makan pada anak dan remaja juga memasukkan aspek pengendalian makan sebagai salah satu dimensi yang dikaji dalam penggunaan DEBQ (Maneschy et al., 2024).

c. External Eating

External eating merupakan kecenderungan individu untuk makan sebagai respons terhadap rangsangan eksternal yang berkaitan dengan makanan, seperti tampilan, aroma, atau ketersediaan makanan di lingkungan sekitar. Pada kecenderungan ini, daya tarik makanan dapat mendorong individu untuk makan meskipun rasa lapar bukan satu-satunya pemicu. Dalam DEBQ, aspek *external eating* digunakan untuk mengukur kecenderungan individu dalam merespons rangsangan makanan dari lingkungan (van Strien et al., 1986). Pada anak dan remaja, respons terhadap

rangsangan makanan juga menjadi salah satu aspek yang relevan dalam kajian perilaku makan dan hubungannya dengan konsumsi makanan (Maneschy et al., 2024).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Makan

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang berperan dalam pembentukan perilaku makan remaja. Kebiasaan makan yang diterapkan di rumah, ketersediaan makanan, serta pola interaksi keluarga dapat membentuk kebiasaan dan pilihan makanan remaja. Selain itu, perubahan dalam kehidupan keluarga, seperti semakin padatnya aktivitas orang tua dan berkurangnya kebiasaan makan bersama, dapat memengaruhi pola makan remaja. Penelitian mengenai remaja Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan rumah, sekolah, dan teman sebaya secara bersama-sama berperan dalam membentuk perilaku makan, termasuk kebiasaan sarapan dan pemilihan makanan (Rachmi et al., 2021). Dengan demikian, keluarga menjadi salah satu lingkungan penting dalam membentuk kebiasaan makan yang dapat terbawa hingga masa dewasa.

b. Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi perilaku makan remaja. Pada masa remaja, interaksi dengan teman sebaya semakin meningkat sehingga aktivitas makan sering kali dilakukan bersama teman. Kondisi tersebut dapat

memengaruhi pilihan makanan dan kebiasaan konsumsi melalui proses penyesuaian terhadap kebiasaan kelompok. Selain pilihan makanan, interaksi dengan teman sebaya juga dapat memengaruhi pandangan remaja terhadap tubuh dan penampilan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan teman sebaya dapat berperan dalam pembentukan perilaku makan dan sikap terhadap makanan pada masa remaja (Rachmi et al., 2021). Selain itu, pembicaraan mengenai tubuh (*body talk*) dalam lingkungan teman sebaya dapat berkaitan dengan munculnya perhatian negatif terhadap tubuh dan sikap yang berhubungan dengan gangguan makan pada remaja putri (Barbeau et al., 2022). Oleh karena itu, pengaruh teman sebaya perlu diperhatikan sebagai salah satu faktor sosial yang dapat membentuk perilaku makan remaja.

c. Media

Perkembangan media digital, khususnya media sosial, menyebabkan remaja semakin sering terpapar informasi mengenai makanan, pola diet, gaya hidup, dan standar penampilan. Konten tersebut dapat memengaruhi persepsi serta preferensi remaja terhadap makanan dan tubuhnya. Penelitian pada remaja di Jakarta dan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa penggunaan Instagram berkaitan dengan *body dissatisfaction* dan perilaku makan, meskipun intensitas penggunaan Instagram secara langsung tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perilaku makan

(Wassalwa & Khomsan, 2023). Sementara itu, penelitian pada remaja usia 16–18 tahun di Kabupaten Tangerang menemukan adanya hubungan antara penggunaan media sosial dengan pola konsumsi *fast food* (Suci at al., 2024). Dengan demikian, media sosial dapat menjadi salah satu lingkungan yang memberikan paparan terhadap berbagai stimulus makanan dan informasi mengenai tubuh yang berpotensi memengaruhi perilaku makan remaja.

d. Citra Tubuh

Citra tubuh merupakan persepsi dan penilaian individu terhadap bentuk, ukuran, berat, serta penampilan tubuhnya. Pada masa remaja, perhatian terhadap penampilan fisik dapat meningkat seiring dengan perubahan tubuh dan adanya standar penampilan yang berkembang di lingkungan sosial. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara remaja memandang tubuhnya dan selanjutnya berkaitan dengan perilaku makan. Penelitian pada 2.160 remaja Indonesia berusia 12–18 tahun menunjukkan bahwa persepsi terhadap tubuh berkaitan dengan perilaku diet dan konsumsi makanan tertentu, terutama pada remaja perempuan dengan status gizi lebih atau obesitas (Niswah et al., 2021). Penelitian pada remaja putri di Bandung juga menunjukkan adanya perbedaan pada beberapa aspek persepsi citra tubuh berdasarkan status gizi, seperti evaluasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kekhawatiran

terhadap berat badan, dan persepsi terhadap berat badan (Prameswari et al., 2022). Selain itu, penelitian pada siswa SMA di Bogor menunjukkan adanya hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan citra tubuh serta hubungan antara citra tubuh dan status gizi (Dina dan Rahman, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa citra tubuh merupakan salah satu faktor psikologis yang relevan dalam memahami perilaku dan kebiasaan terkait makanan pada remaja.

3. Pengukuran Perilaku Makan

Dalam berbagai penelitian, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku makan, khususnya perilaku makan yang berkaitan dengan pola dan kebiasaan konsumsi makanan. Beberapa alat ukur yang dapat digunakan antara lain:

a. *The Eating Attitude Test* (EAT-26)

The Eating Attitude Test (EAT-26) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Garner dan Garfinkel (1979) untuk mengidentifikasi sikap dan perilaku yang berkaitan dengan gangguan makan. Instrumen ini digunakan untuk menilai berbagai karakteristik yang berhubungan dengan perilaku makan, terutama yang berkaitan dengan gangguan makan seperti *anorexia nervosa* dan *bulimia nervosa*.

b. *Adolescent Food Habit Checklist* (AFHC)

Adolescent Food Habit Checklist (AFHC) merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kebiasaan makan pada remaja. Kuesioner ini menggunakan pilihan jawaban "ya" atau "tidak" pada setiap pertanyaan. Responden akan memperoleh satu poin untuk setiap jawaban yang menunjukkan kebiasaan atau perilaku makan yang sehat. Selanjutnya, seluruh poin dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Hasil skor tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan kategori perilaku makan, yaitu perilaku makan baik apabila skor yang diperoleh ≥ nilai rata-rata dan perilaku makan tidak baik apabila skor yang diperoleh < nilai rata-rata.

c. *Dutch Eating Behavior Questionnaire* (DEBQ)

Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Van Strien et al. (1986) untuk mengukur perilaku makan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu *emotional eating*, *restrained eating*, dan *external eating*. *Emotional eating* berkaitan dengan kecenderungan makan sebagai respons terhadap kondisi emosional, *restrained eating* berkaitan dengan usaha individu dalam membatasi atau mengendalikan asupan makanan, sedangkan *external eating* berkaitan dengan kecenderungan makan sebagai respons terhadap rangsangan eksternal yang berhubungan dengan makanan.

B. Tinjauan Umum Remaja

1. Definisi

Menurut WHO (2025) remaja adalah individu berusia antara 10 hingga 19 tahun, dan Ini adalah tahap unik dalam perkembangan manusia dan waktu yang penting untuk meletakkan dasar-dasar kesehatan yang baik. Remaja mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial yang pesat. Hal ini memengaruhi cara mereka merasa, berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Berdasarkan uraian tersebut, remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan tersebut turut mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan perilaku selama proses menuju kedewasaan (Ardiansyah, 2022).

2. Perubahan Fisik Remaja

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan fisik dan biologis yang berlangsung secara cepat. Pubertas menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut dan ditandai dengan percepatan pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perubahan komposisi dan bentuk tubuh. Waktu dan kecepatan perubahan pubertas dapat berbeda pada setiap individu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis kelamin dan kondisi kesehatan serta gizi. Pada remaja perempuan, perubahan pubertas antara lain ditandai dengan perkembangan payudara dan dimulainya menstruasi, sedangkan

pada remaja laki-laki dapat ditandai dengan perubahan suara, perkembangan organ reproduksi, serta peningkatan massa otot dan pertumbuhan fisik. Secara umum, masa remaja merupakan salah satu periode dengan pertumbuhan fisik yang paling cepat setelah masa bayi (*World Health Organization* [WHO], 2024).

Perubahan fisik yang berlangsung cepat selama pubertas tidak hanya berkaitan dengan perkembangan biologis, tetapi juga dapat memengaruhi cara remaja memandang dan menilai tubuhnya. Perubahan tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, dan komposisi tubuh dapat membuat remaja menjadi lebih memperhatikan penampilan fisiknya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepuasan terhadap tubuh dan membentuk citra tubuh selama masa remaja. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa perkembangan citra tubuh berbeda berdasarkan jenis kelamin dan usia. Pada perempuan, citra tubuh secara rata-rata cenderung mengalami penurunan antara usia 10 hingga 16 tahun, sedangkan pada laki-laki ditemukan pola perubahan yang lebih berfluktuasi dengan kecenderungan perbaikan antara usia 10 hingga 24 tahun (Lacroix et al., 2023). Dengan demikian, perubahan fisik selama masa pubertas merupakan salah satu aspek perkembangan yang perlu diperhatikan dalam memahami pembentukan citra tubuh pada remaja.

3. Perkembangan Psikososial Remaja

Menurut Sarwono (2013), perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan dapat dibedakan menjadi tiga

tahap, yaitu remaja awal (*early adolescence*), remaja madya (*middle adolescence*), dan remaja akhir (*late adolescence*).

a. Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Remaja awal berada pada rentang usia 12–14 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh serta munculnya dorongan-dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Remaja mulai mengembangkan pemikiran dan ketertarikan baru, termasuk ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada periode ini, remaja juga memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan pengendalian terhadap ego yang masih berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan remaja awal terkadang mengalami kesulitan dalam memahami orang dewasa maupun membuat dirinya dipahami oleh orang lain (Sarwono, 2013).

b. Remaja Madya **(***Middle Adolescence***)**

Remaja madya berada pada rentang usia 15–18 tahun. Pada tahap ini, keberadaan teman sebaya menjadi semakin penting bagi remaja. Remaja cenderung merasa senang apabila mendapatkan penerimaan dan perhatian dari banyak teman. Pada periode ini juga terdapat kecenderungan untuk lebih memperhatikan dan menyukai diri sendiri serta memilih teman yang dianggap memiliki karakteristik atau kesamaan dengan dirinya. Di sisi lain, remaja madya dapat mengalami kebingungan dalam menentukan sikap dan pilihan, misalnya antara menjadi peka atau tidak peduli, memilih

untuk bersama kelompok atau menyendiri, serta menentukan pandangan yang idealis maupun materialistis (Sarwono, 2013).

c. Remaja Akhir **(***Late Adolescence***)**

Remaja akhir berada pada rentang usia 18–21 tahun dan merupakan tahap konsolidasi menuju masa dewasa. Pada tahap ini, perkembangan remaja ditandai dengan semakin mantapnya minat terhadap kemampuan intelektual. Remaja juga mulai memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan orang lain serta memperoleh pengalaman baru. Selain itu, identitas seksual mulai terbentuk secara lebih stabil. Egosentrisme yang sebelumnya lebih dominan secara bertahap berkembang menjadi kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Pada tahap ini, remaja juga mulai mampu membedakan kehidupan pribadi (*private self*) dengan kehidupan yang ditampilkan kepada masyarakat (*the public*) (Sarwono, 2013).

C. Tinjauan Umum Citra Tubuh

1. Definisi

Citra tubuh merupakan konstruk psikologis yang menggambarkan bagaimana seseorang memandang, menilai, merasakan, dan merespons tubuh serta penampilannya. Citra tubuh tidak hanya berkaitan dengan persepsi mengenai ukuran, bentuk, dan berat badan, tetapi juga mencakup pikiran, keyakinan, perasaan, serta penilaian individu terhadap karakteristik fisik dan penampilannya. Dengan demikian, citra

tubuh bersifat multidimensional dan dapat mencakup aspek kognitif, emosional, evaluatif, maupun perilaku terhadap tubuh (Lacroix et al., 2023).

Citra tubuh tidak bersifat tetap, tetapi dapat mengalami perubahan sepanjang perkembangan individu. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan fisik, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, serta standar penampilan yang berkembang di masyarakat. Pada masa remaja, perubahan fisik yang berlangsung selama pubertas dapat meningkatkan perhatian terhadap penampilan dan membuat remaja semakin memperhatikan bagaimana tubuhnya terlihat dibandingkan dengan orang lain. Perkembangan citra tubuh juga menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Hasil meta-analisis longitudinal menunjukkan bahwa citra tubuh pada perempuan cenderung mengalami penurunan antara usia 10–16 tahun, sedangkan pada laki-laki menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan hingga masa dewasa awal (Lacroix et al., 2023).

Citra tubuh dapat berkembang dalam bentuk positif maupun negatif. Citra tubuh positif ditandai dengan penerimaan dan penghargaan terhadap tubuh, termasuk kemampuan untuk menerima kondisi fisik tanpa memberikan penilaian negatif secara berlebihan. Sebaliknya, citra tubuh negatif dapat ditunjukkan melalui ketidakpuasan terhadap bentuk, ukuran, berat, atau penampilan tubuh. Ketidakpuasan tersebut dapat disertai dengan kekhawatiran yang berlebihan terhadap penampilan dan

keinginan untuk mengubah bentuk tubuh. Penelitian pada remaja perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden tidak memiliki tingkat *body esteem* yang tinggi, sementara sebagian responden juga melaporkan perilaku seperti membatasi asupan makanan, *emotional eating*, dan melakukan aktivitas fisik secara berlebihan (Garbett et al., 2023).

Citra tubuh juga memiliki keterkaitan dengan perilaku makan. Persepsi individu terhadap tubuhnya dapat memengaruhi cara seseorang mengatur dan merespons makanan. Ketidakpuasan terhadap tubuh dapat mendorong individu untuk melakukan pembatasan makanan atau melakukan upaya tertentu untuk mengubah berat dan bentuk tubuh. Pada remaja Indonesia, penelitian terhadap 2.160 remaja usia 12–18 tahun menunjukkan bahwa persepsi terhadap tubuh berkaitan dengan perilaku diet dan beberapa perilaku konsumsi makanan, khususnya pada remaja dengan status gizi lebih atau obesitas (Niswah et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, citra tubuh dapat dipahami sebagai gambaran dan penilaian subjektif individu terhadap tubuh dan penampilannya yang melibatkan aspek pikiran, perasaan, persepsi, dan sikap. Penilaian tersebut dapat bersifat positif maupun negatif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman serta lingkungan sosial. Pada remaja, citra tubuh menjadi aspek penting karena perubahan fisik dan meningkatnya perhatian terhadap penampilan dapat memengaruhi bagaimana remaja

memandang dirinya serta berhubungan dengan perilaku yang berkaitan dengan makanan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh

Citra tubuh terbentuk melalui proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari individu maupun lingkungan sosialnya. Cash dan Pruzinsky (2002) menjelaskan bahwa pengalaman terhadap tubuh dipengaruhi oleh karakteristik fisik, jenis kelamin, keluarga, serta faktor sosiokultural. Pada masa remaja, faktor-faktor tersebut menjadi semakin penting karena remaja mengalami perubahan fisik yang cepat dan mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap penampilan serta penilaian sosial. Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian terbaru, beberapa faktor yang berkaitan dengan citra tubuh remaja adalah sebagai berikut.

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan citra tubuh. Remaja perempuan cenderung mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan adanya tuntutan penampilan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Remaja perempuan lebih sering dihadapkan pada standar tubuh yang langsing, sedangkan laki-laki lebih banyak menghadapi tuntutan untuk memiliki tubuh yang berotot atau atletis.

Penelitian mengenai perkembangan citra tubuh pada anak dan remaja juga menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, dengan perempuan cenderung memiliki kekhawatiran terhadap tubuh yang lebih besar dibandingkan laki-laki (Mäkinen et al., 2024).

b. Usia

Usia juga berhubungan dengan perkembangan citra tubuh karena masa remaja merupakan periode yang ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara cepat. Seiring bertambahnya usia, remaja mengalami perkembangan dalam memahami dirinya serta dalam menilai penampilan dan tubuhnya. Perkembangan citra tubuh dapat mengalami perubahan sepanjang masa remaja dan menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan usia serta jenis kelamin. Meta-analisis longitudinal menunjukkan bahwa citra tubuh pada perempuan cenderung mengalami penurunan selama masa remaja, sedangkan laki-laki menunjukkan pola perkembangan yang berbeda (Lacroix et al., 2023).

c. Perubahan Fisik

Perubahan fisik merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan citra tubuh pada masa remaja. Pubertas menyebabkan perubahan pada tinggi badan, berat badan, bentuk, serta komposisi tubuh. Perubahan tersebut dapat meningkatkan

perhatian remaja terhadap penampilan fisiknya. Apabila perubahan tubuh yang dialami tidak sesuai dengan bentuk tubuh yang diharapkan atau standar penampilan yang berlaku di lingkungan sosial, remaja dapat mengalami ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Perubahan fisik selama masa pubertas juga menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan citra tubuh karena periode tersebut merupakan masa terjadinya perubahan biologis dan psikososial yang cukup besar (Cash & Pruzinsky, 2002; Garbett et al., 2023).

d. Media

Media, khususnya media sosial, merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi citra tubuh remaja. Paparan terhadap gambar tubuh ideal dan standar penampilan tertentu dapat mendorong remaja membandingkan penampilan dirinya dengan orang lain. Ketika terdapat perbedaan antara kondisi tubuh yang dimiliki dengan standar tubuh yang ditampilkan melalui media, remaja dapat mengalami ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Penelitian pada remaja di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial yang menampilkan figur tubuh ideal dapat mendorong remaja melakukan perbandingan terhadap bentuk tubuhnya dan berkaitan dengan *body dissatisfaction*, perilaku makan, serta status gizi (Wassalwa & Khomsan, 2023).

e. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang berperan dalam pembentukan citra tubuh remaja. Komentar, penilaian, maupun sikap anggota keluarga terhadap berat badan dan penampilan dapat memengaruhi cara remaja memandang tubuhnya. Komentar negatif mengenai bentuk atau berat badan dapat meningkatkan perhatian remaja terhadap penampilannya dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap tubuh. Sebaliknya, penerimaan dan dukungan dari keluarga dapat membantu remaja mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap tubuhnya. Keluarga juga termasuk salah satu sumber pengaruh sosiokultural yang berperan dalam pembentukan citra tubuh (Cash & Pruzinsky, 2002). Penelitian pada remaja perempuan di Indonesia juga menunjukkan bahwa keluarga dapat menjadi salah satu sumber *appearance-related teasing*, yang berkaitan dengan *body esteem* (Garbett et al., 2023).

f. Hubungan Interpersonal dan Teman Sebaya

Hubungan interpersonal, terutama dengan teman sebaya, memiliki peran dalam perkembangan citra tubuh remaja. Pada masa remaja, penerimaan sosial dan penilaian dari teman sebaya menjadi semakin penting. Komentar mengenai penampilan, perbandingan bentuk tubuh, maupun ejekan terkait penampilan dapat memengaruhi cara remaja mengevaluasi tubuhnya. Penelitian pada

remaja perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa *appearance-related teasing* berhubungan dengan *body esteem*. Pada remaja yang lebih muda, pengalaman ejekan terkait penampilan menjadi salah satu faktor yang secara signifikan berkaitan dengan *body esteem*, sedangkan pada kelompok remaja yang lebih tua, *appearance-related teasing* juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan *body esteem* (Garbett et al., 2023).

g. Status Gizi

Status gizi juga dapat berkaitan dengan citra tubuh karena kondisi berat badan dan bentuk tubuh dapat memengaruhi cara individu menilai penampilannya. Remaja yang memiliki kelebihan berat badan dapat memiliki perhatian yang lebih besar terhadap bentuk dan berat tubuhnya, terutama ketika kondisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan standar penampilan yang berlaku. Penelitian pada remaja perempuan di Indonesia menemukan bahwa BMI berhubungan secara unik dengan *body esteem* pada kelompok remaja perempuan usia 10–13 tahun setelah mempertimbangkan faktor psikososial lainnya (Garbett et al., 2023). Selain itu, penelitian di Indonesia mengenai remaja menunjukkan adanya keterkaitan antara *body dissatisfaction*, perilaku makan, dan status gizi (Wassalwa & Khomsan, 2023).

3 Aspek – Aspek Citra Tubuh

Kepuasan dan ketidakpuasan terkait kondisi tubuh dapat diukur melalui beberapa aspek pada citra tubuh. Cash dalam (Ramanda et al., 2019) menguraikan aspek-aspek dalam citra tubuh, terdiri dari:

a. Evaluasi penampilan *(Appearance evaluation)*

   Persepsi individu terhadap bentuk tubuh dan penampilannya, termasuk bagaiamana individu menilai daya tarik dan tingkat kepuasan terhadap keseluruhan kondisi fisiknya.

b. Orientasi penampilan *(Appearance orientation)*

   Usaha yang dilakukan individu untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilannya.

c. Kepuasan terhadap bagian tubuh *(Body area satisfaction)*

   Menggambarkan tingkat kepuasan individu terhadap bagian-bagian tubuh tertentu, meliputi wajah, tubuh pada bagian atas misalnya lengan, dada dan bahu, lalu tubuh bagian tengah seperti perut dan pinggang, tubuh bagian bawah seperti pinggul, paha, bokong, dan kaki, serta penampilan tubuh secara keseluruhan.

d. Kecemasan menjadi gemuk *(Overweight preoccupation)*

   Menggambarkan kekhawatiran individu terhadap kondisi kegemukan yang ditandai dengan perhatian terhadap berat badan, kecenderungan untuk melakukan diet, serta upaya membatasi pola makan.

e. Pengkategorian ukuran tubuh *(Self Classified Weight)*

Menggambarkan penilaian individu terhadaap berat badannya, dengan mengkategorikannya apakaha dia termasuk normal, kurus atau gemuk.

D. Hubungan antara Citra Tubuh dengan Perilaku Makan pada Remaja

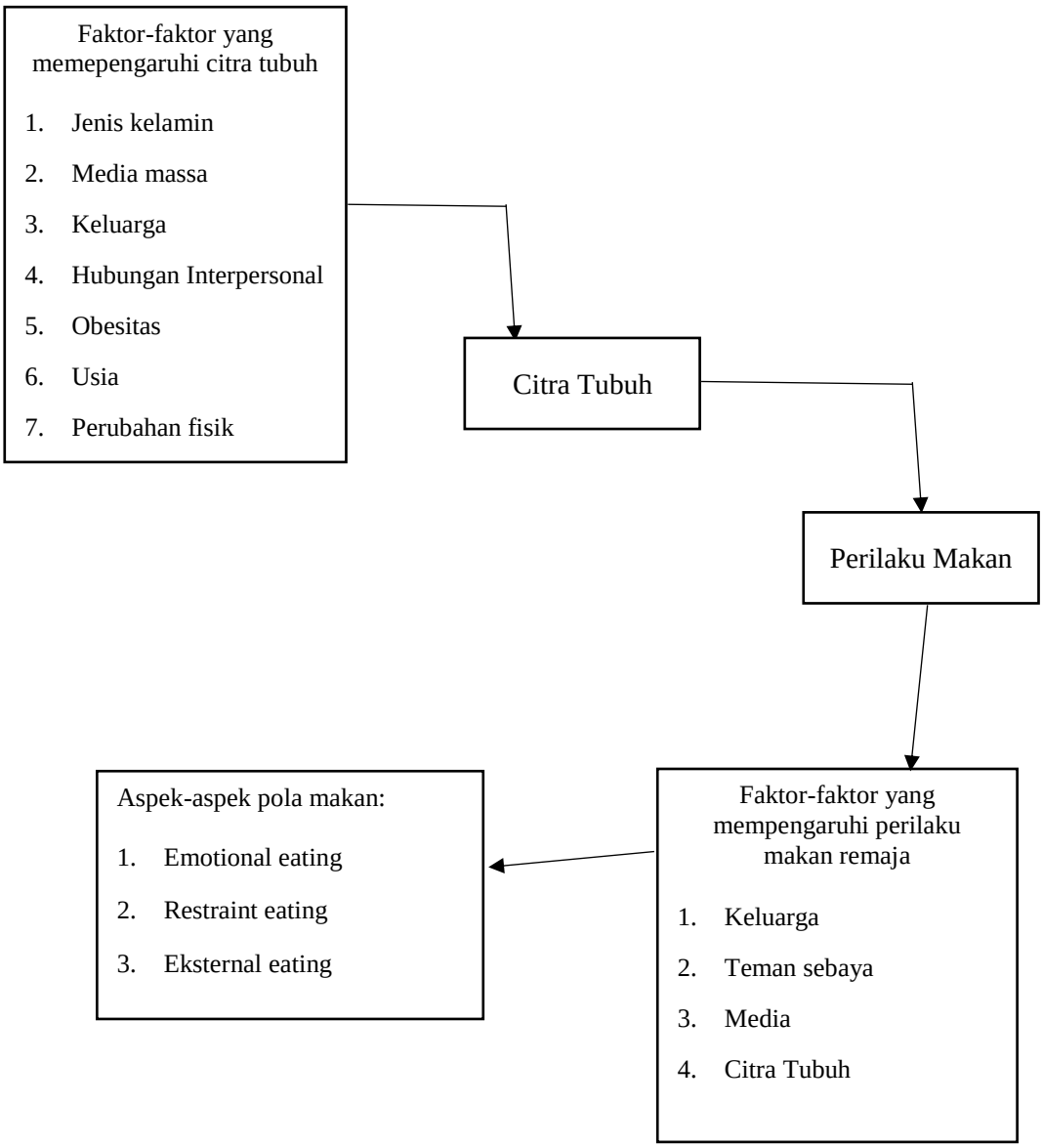
Pada masa remaja, perubahan fisik pada masa remaja akan membuat mereka lebih memperhatikan bentuk dan penampilan tubuhnya. Penilaian tubuh pada remaja tidak selalu sama setiap individunya. Ada yang bisa menerima bentuk tubuhnya tetapi ada juga yang kurang puas terhadap bentuk tubuhnya karena belum sesuai seperti gambaran tubuh yang diinginkan. Ketika ketidakpuasan tersebut semakin besar, maka perhatian remaja terhadap makanan dan berat badan juga akan semakin meningkat. Kondisi ini akan mulai membuat remaja mengatur pola makan, membatasi makanan tertentu, atau mengubha jumlah makanan yang dikomsumsi sebagai usaha untuk mendapatkan tubuh yang ideal. (Garbett et al., 2023).

Citra tubuh kemudian dapat berhubungan dengan perilaku makan melalui cara remaja merespons ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Remaja yang merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya dapat lebih mudah melakukan pengaturan makan karena adanya keinginan untuk menurunkan atau mempertahankan berat badan. Sebaliknya, remaja yang lebih menerima kondisi tubuhnya dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan makanan dan tidak terlalu menjadikan perubahan bentuk tubuh sebagai alasan untuk membatasi makanan. Hubungan ini tidak berarti bahwa citra

tubuh menjadi satu-satunya hal yang menentukan perilaku makan, karena perilaku makan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, media, serta pengalaman pribadi remaja. (Wangu et al., 2023).

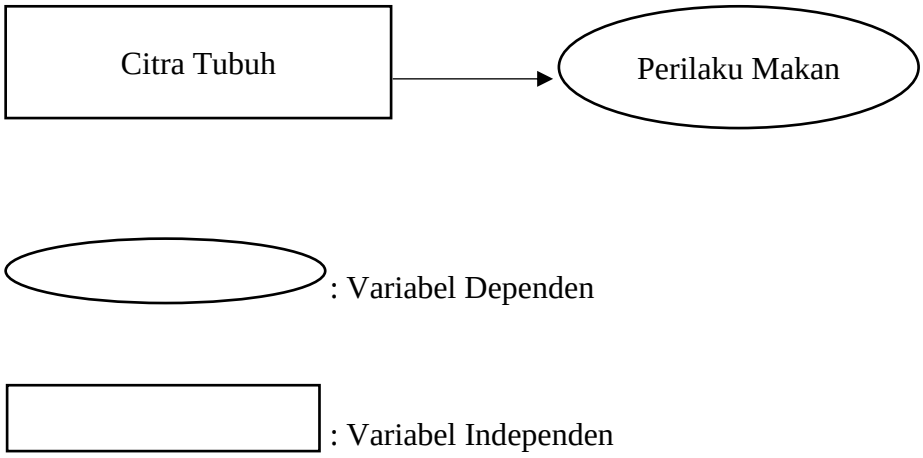
Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian Wangu et al. (2023) yang membahas hubungan citra tubuh dengan perilaku makan pada remaja. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan cross-sectional dan menilai citra tubuh menggunakan MBSRQ-AS serta perilaku makan menggunakan EAT-26. Selain itu, penelitian Bunsal et al. (2025) juga menunjukkan bahwa citra tubuh berkaitan dengan regulasi makan pada siswa SMA, yang menggambarkan bahwa bagaimana remaja memandang tubuhnya dapat berkaitan dengan cara mereka mengatur perilaku makannya. Dengan demikian, citra tubuh menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami perilaku makan remaja, terutama ketika remaja mulai memberikan perhatian yang besar terhadap bentuk dan berat badannya. (Wangu et al., 2023; Bunsal et al., 2025).

E. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

Hipotesis Penelitian

H0 = Tidak ada hubungan antara Persepsi Citra Tubuh dengan perilaku makan remaja di Kendari

Ha = Ada hubungan antara Persepsi Citra Tubuh dengan perilaku makan remaja di Kendari

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan analitik. Desain yang digunakan juga *cross sectional* yang merupakan proses mengumpulkan data dilaksanakan dalam satu waktu agar mengetahui hubungan dari persepsi remaja terhadp gambaran citra tubuh dengan perilaku makan remaja di Kota Kendari. Metode ini dipilih karena dianggap paling efisien terhadap menilai hubungan antar variabel tanpa butuh pengamatan jangka panjang.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September sampai Desember 2026. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 2 Kota Kendari

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang relevan (Iba & Wardhana, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Siswa dengan usia 15-17 tahun yang bersekolah di SMAN 2 Kota Kendari yaitu sebanyak 904 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Sampel mengandung karakteristik yang serupa dengan populasi yang lebih besar, yang memungkinkan penggunaannya dalam analisis statistik ketika populasi terlalu besar untuk mengakomodasi seluruh anggota atau pengamatan yang mungkin ada (Iba & Wardhana, 2023). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *probability sampling* dengan metode *cluster sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kelompok atau klaster yang sudah terbentuk secara alami. Pada penelitian ini, klaster yang digunakan adalah tingkat kelas, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Beberapa kelas dari masing-masing tingkat dipilih secara acak sebagai klaster penelitian, kemudian siswa dalam klaster terpilih dijadikan responden. Perhitungan besar sampel ini menggunakan rumus besar sampel yaitu Rumus Lemeshow dimA = $\pi r^2 ana$ tingkat signifikasi atau tingkat kesalahan yang digunakan yaitu 10% (d = 0,1), dimana tingkat keyakinan 95% (Z = 1,96) (Lee, M., Et al., 2024) adapun Rumus Lemeshow untuk menentukan jumlah sampel jika populasinya diketahui yaitu:

$$n = \frac{N.Z^2.P(1-P)}{(N-1)d^2+Z^2.P(P-1)}$$

keterangan:

n = besar sampel minimum

N = besar populasi

ZI-$\alpha/2$ = nilai distribusi normal baku (1,96)

P = harga proporsi di populasi (0,5)

d = presisi (tingkat kesalahan yang bisa ditolerir) 10% (0,1)

n = $\frac{N.Z^2.P(1-P)}{(N-1)d^2+Z^2.P(P-1)}$

n = $\frac{904.1{,}96^2.0{,}5(1-0{,}5)}{(904-1)0{,}1^2+1{,}96^2.0{,}5(0{,}5-1)}$

n = $\frac{904.1{,}96^2.0{,}5.0{,}5}{(903)0{,}1^2+1{,}96^2.0{,}5.0{,}5}$

n = $\frac{904.3{,}84.0{,}5.0{,}5}{(903)0{,}01+3{,}84.0{,}5.0{,}5}$

n = $\frac{904\ (3{,}84)0{,}5.0{,}5}{9{,}03+0{,}96}$

n = $\frac{868}{9{,}99}$

n = 87

3. Kriteria Sampel

   a. Kriteria Inklusi

      1) Remaja berusia 15-17 tahun

      2) Terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah tempat penelitian

      3) Bersedia menjadi responden

      4) Dapat membaca dan memahami kuesioner dengan baik

      5) Mengisi kuesioner secara lengkap

   b. Kriteria Eksklusi

      1) Remaja yang tidak hadir pada saat pengambilan data

      2) Responden yang mengisi kuesioner secara tidak lengkap atau tidak sesuai instruksi

3) Responden yang menolak penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data / Prosedur Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder**.** Data sekunder diperoleh dari pihak sekolah tempat penelitian, yaitu informasi mengenai jumlah keseluruhan siswa kelas X dan XI yang terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah tersebut. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar populasi dan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden, yaitu siswa kelas X dan XI yang memenuhi kriteria inklusi.

1. Alat dan Bahan Penelitian

a. Kuisoner

1) Kuseioner data demografi

Menggunakan instrumen yang berisikan identitas responden yang terdiri dari nama, jenis kelamin, usia, kelas, berat badan dan tinggi badan.

2) Kuesioner persepsi citra tubuh

Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi terhadap citra tubuh adalah Body Shape Questionnaire-16A (BSQ-16A) yang dikembangkan oleh Evans dan Dolan (1993) sebagai bentuk singkat dari Body Shape Questionnaire (BSQ-34). BSQ-16A terdiri atas 16 pernyataan dengan enam pilihan jawaban, yaitu 1 = tidak pernah, 2 = jarang, 3 = kadang-kadang,

4 = sering, 5 = sangat sering, dan 6 = selalu. Setiap jawaban diberi skor 1–6, sehingga total skor berkisar antara 16–96. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kekhawatiran atau ketidakpuasan responden terhadap bentuk tubuhnya.

3) Kuesioner perilaku makan

Menggunakan instrumen Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) yang dikembangkan oleh Van Strien et al. (1986). Kuesioner ini digunakan untuk mengukur perilaku makan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu restrained eating, emotional eating, dan external eating. Restrained eating menggambarkan kecenderungan individu untuk membatasi atau mengontrol asupan makanan, emotional eating menggambarkan kecenderungan makan sebagai respons terhadap kondisi emosional, sedangkan external eating menggambarkan kecenderungan makan sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan. Kuesioner DEBQ terdiri dari 33 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 = tidak pernah, 2 = jarang, 3 = kadang-kadang, 4 = sering, dan 5 = selalu. Skor diperoleh dari jawaban responden pada setiap pertanyaan dan kemudian digunakan untuk menggambarkan kecenderungan perilaku makan pada masing-masing aspek. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi kecenderungan

perilaku makan pada aspek yang diukur.

b. Alat tulis

c. Google form (terantung kondisi jika online)

d. Laptop atau Hp

e. Daftar hadir responden

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Persepsi Terhadap Gambaran Citra Tubuh

a. Definisi Operasional

Persepsi terhadap gambaran tubuh adalah cara remaja menilai, merasakan, dan memandang bentuk tubuh, ukuran tubuh, serta penampilannya. Penilaian ini mencakup tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan remaja terhadap tubuhnya, yang dapat memengaruhi perilaku dan kebiasaan makan. Persepsi ini diukur melalui kuesioner citra tubuh yang diisi secara mandiri oleh responden.

b. Kriteria Objektif

Penilaian persepsi terhadap citra tubuh dilakukan berdasarkan total skor Body Shape Questionnaire-16A (BSQ-16A). Setiap item diberi skor 1–6, sehingga total skor berada pada rentang 16–96. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Berdasarkan pengelompokan skor BSQ-16A, kriteria objektif penilaian adalah sebagai berikut:

1). Tidak ada kekhawatiran terhadap bentuk tubuh: skor <38

2). Kekhawatiran ringan: skor 38-51

3). Kekhawatiran sedang: skor 52-66

4). Kekhawatiran berat: skor >66

c. Skala Ukur

Skala Ukur Ordinal

2. Perilaku Makan Remaja

a. Definisi Operasional

Perilaku makan adalah kebiasaan remaja dalam memilih makanan, frekuensi makan, jenis makanan yang dikonsumsi, serta cara makan sehari-hari. Penilaian perilaku makan mencakup aspek *emotional eating*, *restraint eating*, dan *external eating* yang diukur melalui kuesioner perilaku makan yang diisi oleh responden.

b. Kriteria Objektif

Penilaian perilaku makan berdadasarkan skor kuesioner DEBQ, yaitu:

1) *Emotional eating*: skor aspek *emotional eating* diperoleh dari jumlah skor item pada aspek tersebut.

2) *Restrained eating*: skor aspek *restrained eating* diperoleh dari jumlah skor item pada aspek tersebut.

3) External eating: skor aspek *external eating* diperoleh dari jumlah skor item pada aspek tersebut

c. Skala Ukur

Skala ukur Ordinal

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis secara tersturktur:

1. Analisis Univariat

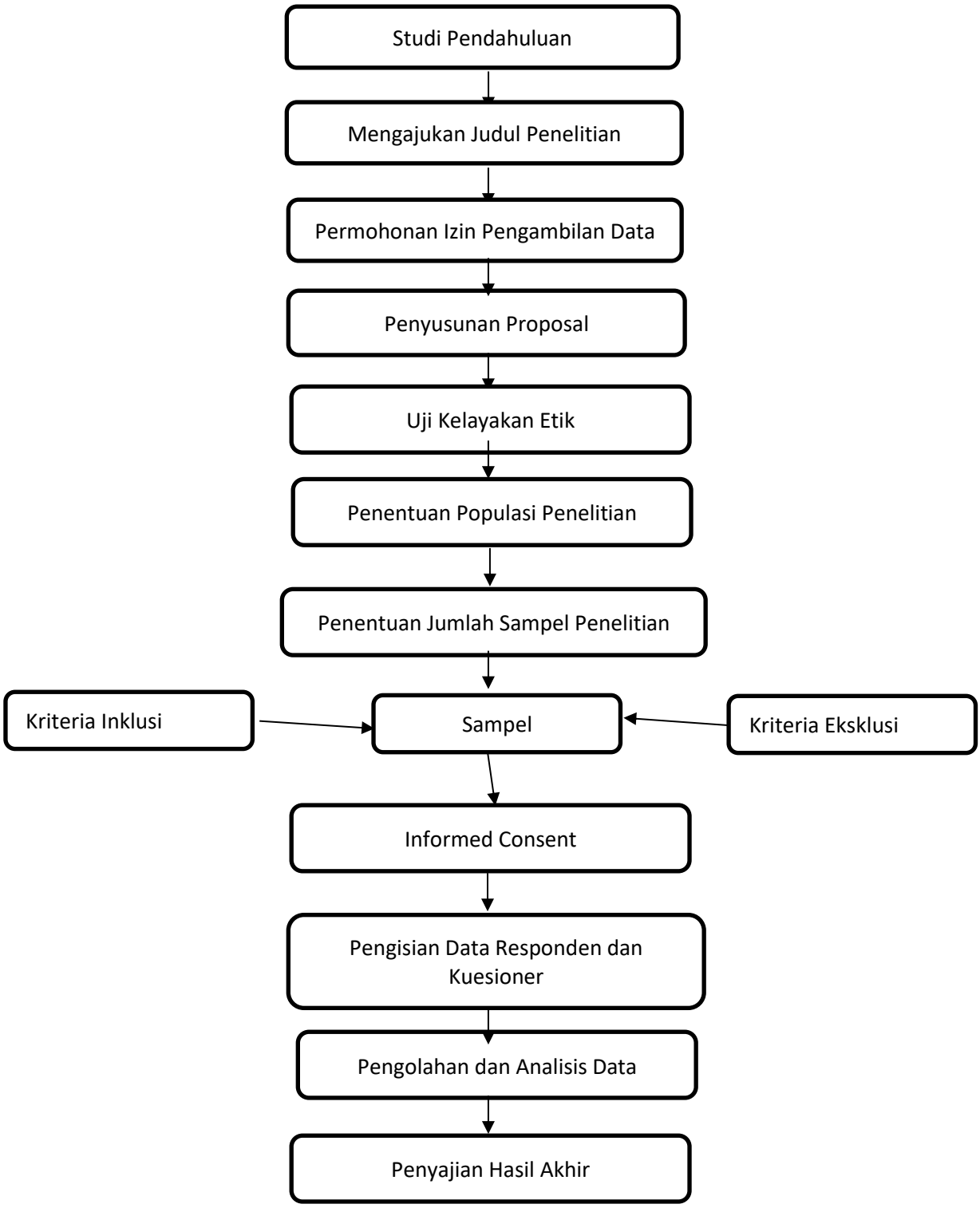
Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian, yaitu persepsi terhadap citra tubuh dan perilaku makan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk memberikan gambaran mengenai masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis bivariat.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu persepsi terhadap citra tubuh, dengan variabel dependen, yaitu perilaku makan remaja di Kota Kendari. Perilaku makan diukur menggunakan Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) yang terdiri dari tiga subskala, yaitu emotional eating, restrained eating, dan external eating. Oleh karena itu, hubungan antara persepsi terhadap citra tubuh dengan perilaku makan dianalisis pada masing-masing subskala DEBQ menggunakan uji statistik Spearman Rank dengan bantuan program SPSS. Uji Spearman Rank digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara skor persepsi terhadap citra tubuh dengan skor pada masing-masing subskala perilaku makan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Spearman Rank adalah:

a. Jika nilai p-value < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap citra tubuh dengan subskala perilaku makan yang dianalisis.
b. Jika nilai p-value > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap citra tubuh dengan subskala perilaku makan yang dianalisis.

G. Alur Penelitian



Gambar 3. Alur Penelitian

H. Etika Penelitian

Etika dalam penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini memperhatikan etika penilaian berikut:

1. Informed Consent

Sebelum melibatkan peserta dalam penelitian, peneliti wajib memperoleh *informed consent*. Proses ini melibatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko dan manfaat, serta hak peserta untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Penggunaan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta sangat spenting untuk memastikan mereka benar-benar memahami informasi yang diberikan.

2. Kerahasiaan data

Kerahasiaan data peserta merupakan hal yang mutlak. Peneliti harus memastikan identitas peserta tetap terjaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode atau nomor pengganti. Data penelitian harus disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk melindungi privasi peserta dan mencegah penyalahgunaan data.

3. Beneficence

Prinsip *beneficence* dimana peneliti melaksanakan prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat, meminimalkan

dampak bagi subjek penelitian dan menjelaskan keuntungan atau manfaat yang didapatkan partisipan dan potensial resiko yang dapat terjadi.

4. *Anonymity*

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberikan nomor kode pada masing-masing lembar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Nirwan Dkk., (2025). Hubungan Persepsi Body Image Dan Pola Makan Dengan Status Gizi Remaja Di Sma Negeri 15 Luwu. Jurnal Media Informatika. Volume 6, Nomor 2. Https://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index.Php/Jumin

Ni'mah., (2022). Hubungan Body Image Dan Perilaku Makan Dengan Status Gizi Remaja Putri Dismk Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Jurnal Gizi Unesa. Volume 02 Nomor 02, 124-128

Purwanti & Marlina., (2022). Gambaran Persepsi Citra Tubuh, Pengetahuan Gizi Seimbang, Dan Perilaku Makan Remaja Putri Di Sma Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Jurnal Kesehatan Komunitas.

Sari, A, P., Metasari, D., Susanti, M, E. (2025). The Relationship Between Body Image And Eating Patterns In Middle Adolescents In Public High School 05 Bengkulu City In 2024. Jurnal Multidisiplin. 1(4). Doi:Https://Doi.Org/10.70963/Jm.V1i4

Amir Dkk., (2023). Hubungan Citra Tubuh Dengan Status Gizi Pada Remaja Sman 4 Maros Kabupaten Maros. Window Of Public Health Journal,Vol. 4 No. 1

Ripta Dkk., (2023). Persepsi Body Image Dan Status Gizi Pada Remaja. Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol. 19 No. 1.

Sukoco Dkk., (2022). Hubungan Pengetahuan Gizi Dan Persepsi Body Image Dengan Kebiasaan Sarapan Pagi Pada Remaja Putri Di Surakarta. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia

Asnia dkk., (2024). Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Status Gizi pada Remaja Putri di SMP Negeri 5 Kendari. Jurnal Medika Nusantara. Volume 3, Nomor 1. https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Medika

Ifdil, Dencih, Amandha Unzilla, & Ilyas, A. (2017). Hubungan Body Image Dengan Kepercayaan Diri Remaja Putri. Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling, 2(3), 107–113

Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. Edukasi Nonformal, 1(Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Edukasi Nonformal), 1–12. Https://Ummaspul.E Journal.Id/Jenfol/Article/View/434

Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 5(2), 121. Https://Doi.Org/10.22373/Je.V5i2.5019

Prameswari, F. S. P., Astuti, W., Rosdiana, D. S., Fauza, A., & Insani, H. M. (2022). Persepsi *body image* dan kualitas konsumsi makanan remaja putri dengan status gizi normal dan lebih di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 1*(3), 216–223. https://doi.org/10.25182/jigd.2022.1.3.216-223

Dina, R. A., & Rahman, N. A. (2025). Hubungan body image, intensitas penggunaan media sosial, kualitas diet, aktivitas fisik dan status gizi pada remaja. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 4*(2), 82–95. https://doi.org/10.25182/jigd.2025.4.2.82-95

Papalia, Diane, & Fedman, S. Wendkos. (2011). Human Development (Psikologi Perkembangan). Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.

Savitri, D., Arini, F. A., & Ilmi, I. M. B. (2023). The correlation between body image and eating behaviour with nutritional status in female adolescents at 104 Senior High School Jakarta. *Journal of Research Innovation and Sustainable Development, 1*(1).

Al Vianita, F., Kurniawati, D., & Juliningrum, P. P. (2020). Description Of Knowledge, Attitude, And Behavioral Breastfeeding On Working Mother In The Arjasa Community Health Center Working Area In Jember Regency. Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal Of Nursing Science), 8(1), 1–9. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jik.2020.008.01.1

Shaw, S., Barrett, M., Shand, C., Cooper, C., Crozier, S., Smith, D., Barker, M., & Vogel, C. (2023). Influences of the community and consumer nutrition environment on the food purchases and dietary behaviors of adolescents: A systematic review. Obesity Reviews, 24(7), e13569. https://doi.org/10.1111/obr.13569

Idayati, At All. (2019). Hubungan Citra Tubuh Dengan Stres Pada Penderita Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu. Jurnal Wacana Kesehatan, 4 No 2, 445–452.

Hasmalawati, N. (2017). Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita. Jurnal Psikoislamedia, 2(2), 107–115.

Limbong, M. M. (2020). Hubungan perilaku makan dan perception of aging dengan status nutrisi lansia di daerah pesisir surabaya. Dalam Skripsi thesis. Universitas Airlangga.

Sari, I. A. W. P., & Suarya, L. M. S. (2018). Hubungan Antara Social Comparison

Dan Harga Diri Terhadap Citra Tubuh Pada Remaja Perempuan Ida Ayu Wika Permata Sari Dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya. Jurnal Psikologi Udayana, 5(2), 265–277.

Nataniel, F., Uch, M., Mac, N., Medeiros, T., & Garrido, N. D. (2019). Ijerph-16-01508-V3.Pdf. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16, 1–14.

Wati, D. K., & Sumarmi, S. (2017). Citra Tubuh Pada Remaja Perempuan Gemuk Dan Tidak Gemuk: Studi Cross Sectional. Amerta Nutrition, 1(4), 398. Https://Doi.Org/10.20473/Amnt.V1i4.7130

Dwi, Cahyaningrum Herlina. (2013). Hubungan Antara Body Image Dengan Status Gizi Pada Remaja Putri Kelas Xi Ips Di Sma Batik 1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ningsih, N. A. (2017). Hubungan Citra Tubuh Terhadap Perilaku Makan Pada Siswi Smp Negeri 11 Medan. Universitas Sumatera Utara.

Sarwono, S. W (2013). Psikologi Remaja. Rajawali Pers

Anugrah Damayanti., (2024). Hubungan Perilaku Makan Tipe Emotional, External Dan Restrained Dengan Status Gizi Pada Remaja Sma Negeri 2 Enrekang. Dalam Skripsi. Universitas Negeri Makassar

Ziora-Jakutowicz KN, Pałasz W, Gorczyca P, Ziora K. Penilaian diri dan persepsi diri terhadap tubuh pada gadis berusia 18 tahun. Metab Diabetes Endokrin Pediatrik. 2023; 29(4):237-247. DOI: 10.5114/PEDM.2023.133313. PMID: 38282492; PMCID: PMC10826689.

Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (Eds.). (2002). *Body image: A handbook of theory,*

research, and clinical practice. Guilford Press.

Garbett, K. M., Craddock, N., Saraswati, L. A., & Diedrichs, P. C. (2023). Body image among girls in Indonesia: Associations with disordered eating behaviors, life engagement, desire for cosmetic surgery and psychosocial influences. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(14), 6394. https://doi.org/10.3390/ijerph20146394

Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The eating attitudes test: Psychometric features and clinical correlates. *Psychological Medicine, 12*(4), 871–878. https://doi.org/10.1017/S0033291700049163

Johnson, F., Wardle, J., & Griffith, J. (2002). The adolescent food habits checklist: Reliability and validity of a measure of healthy eating behaviour in adolescents. *European Journal of Clinical Nutrition, 56*(7), 644–649. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601371

Lacroix, E., Smith, A. J., Husain, I. A., Orth, U., & von Ranson, K. M. (2023). Normative body image development: A longitudinal meta-analysis of mean-level change. *Body Image, 45*, 238–264. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.03.003

Maneschy, I., Jimeno-Martínez, A., Miguel-Berges, M. L., et al. (2024). Eating Behaviours and Dietary Intake in Children and Adolescents: A Systematic Review. Current Nutrition Reports, 13, 363–376. https://doi.org/10.1007/s13668-024-00544-w

van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained,

emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295–315. https://doi.org/10.1002/1098-108X(198602)5:23.0.CO;2-T

Niswah, I., Rah, J. H., & Roshita, A. (2021). The association of body image perception with dietary and physical activity behaviors among adolescents in Indonesia. *Food and Nutrition Bulletin, 42*(1_suppl), S109–S121. https://doi.org/10.1177/0379572120977452

Rachmi, C. N., Jusril, H., Ariawan, I., Beal, T., & Sutrisna, A. (2021). Eating behaviour of Indonesian adolescents: A systematic review of the literature. *Public Health Nutrition, 24*(S2), S84–S97. https://doi.org/10.1017/S1368980020002876

Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. *The Lancet Child & Adolescent Health, 2*(3), 223–228. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1

van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. *International Journal of Eating Disorders, 5*(2), 295–315. https://doi.org/10.1002/1098-108X(198602)5:2<295::AID EAT2260050209>3.0.CO;2-T

Wassalwa, U. S., & Khomsan, A. (2023). Dampak intensitas penggunaan Instagram terhadap *body dissatisfaction*, perilaku makan, dan status gizi pada remaja. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 2*(4), 278–286. https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.4.278-286

World Health Organization. (2024). *Adolescent health*. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health

Lionita, W., Febry, F., Appulembang, Y. A., & Anggraini, R. (2022). Relationship between body image and eating behavior among high school female adolescents. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 17(2), 86–90. https://doi.org/10.14710/jpki.17.2.86-90

Oktaviani, A., & Yunieswati, W. (2023). Body image, perilaku makan dan faktor lainnya dengan status gizi lebih pada remaja putri di SMK Kesehatan Letris. Jurnal Gizi dan Kuliner, 4(2). https://doi.org/10.35706/giziku.v4i2.10903

Rachmi, C. N., Jusril, H., Ariawan, I., Beal, T., & Sutrisna, A. (2021). Eating behaviour of Indonesian adolescents: A systematic review of the literature. Public Health Nutrition, 24(S2), S84–S97. https://doi.org/10.1017/S1368980020002876

Wangu, E. W., Widjayanti, Y., & Silalahi, V. (2023). Citra tubuh (body image) dan perilaku makan pada remaja. JPK: Jurnal Penelitian Kesehatan, 13(1), 7–14. https://doi.org/10.54040/jpk.v13i1.239

Wassalwa, U. S., & Khomsan, A. (2023). Dampak intensitas penggunaan Instagram terhadap body dissatisfaction, perilaku makan, dan status gizi pada remaja. Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 2(4), 278–286. https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.4.278-286

Barbeau, K., Carbonneau, N., & Pelletier, L. (2022). Family members and peers' negative and positive body talk: How they relate to adolescent girls' body talk and eating disorder attitudes. *Body Image*, *40*, 213–224.

https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.12.010

Suci, S. E., Putri, I. E., & Fazriah, H. (2024). Hubungan Enabling dan Predisposing Pola Konsumsi Fast Food pada Remaja Usia 16–18 Tahun di SMAN 6 Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 3(2), 140–146. https://doi.org/10.25182/jigd.2024.3.2.140-146

Ardiansyah. (2022, 10 Juni). Kesehatan reproduksi remaja: Permasalahan dan upaya pencegahan. *Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan

Lampiran 1. Surat Permohonan Menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tereza Devi Sinta

NIM : K1A223010

Status : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo

Dengan ini saya memohon kesediaan Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian yang akan saya lakukan dengan judul **"Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Tubuh Dengan Perilaku Makan Pada Remaja"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dan kelelahan dengan keluhan muskuloskeletal pada mahasiswa Keperawatan Universitas Halu Oleo. Peneliti menghargai hak Saudara/i sebagai responden dalam penelitian ini. Keikutsertaan Saudara/i bersifat sukarela, serta seluruh identitas dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian surat permohonan ini peneliti ajukan. Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i dalam berpartisipasi pada penelitian ini.

Peneliti Kendari, 2026

Yang Membuat Pernyataan

(Terezah Devi Sinta) (.....)

Lampiran 2. *Informed consent*

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Angkatan :

NIM :

Bersedia memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian yang berjudul: **"Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Tubuh Dengan Perilaku Makan Pada Remaja"**

Sebelumnya saya telah dijelaskan bahwa penelitian ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi responden penelitian ini.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Kendari, 2026

Yang Membuat Pernyataan

(……)

Lampiran 3. Data Demografi Responden

A. Data Demografi Responden

Petunjuk :

Silakan isi data berikut sesuai dengan keadaan diri anda dan lingkari. Data yang diberikan akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian.

1. Kode responden :
2. Jenis kelamin : Laki – laki/Perempuan
3. Usia : 15/16/17 tahun
4. Kelas : X/XI
5. Berat badan : Kg
6. Tinggi badan : Cm

‘

Lampiran 4. Kuesioner Citra Tubuh

BSQ-16A

Terdapat 16 pernyataan di bawah ini, berilah penilaian yang sesuai dengan keadaan atau kondisi pada diri Anda sesuai dengan rating sebagai berikut:

1 = Tidak Pernah

2 = Jarang

3 = Kadang-Kadang

4 = Sering

5 = Sangat Sering

6 = Selalu

No.	Pertanyaan	6	5	4	3	2	1
1.	Apakah rasa bosan pernah membuat anda tidak bahagia dengan bentuk tubuh anda?						
2.	Apakah anda pernah berpikir bahwa paha, panggul, dan bokong anda terlalu besar untuk ukuran tubuh anda?						
3.	Apakah anda pernah merasa khawatir bahwa badan anda tidak cukup kencang?						
4.	Pernahkah anda merasa sangat tidak bahagia dengan bentuk tubuh anda sehingga anda menangis?						
5.	Pernahkah anda menghindar untuk berlari karena khawatir (lemak) tubuh Anda akan bergoyang-goyang saat anda berlari?						

No.	Pertanyaan	6	5	4	3	2	1
6.	Apakah berada bersama dengan perempuan langsing pernah membuat anda merasa sensitif akan bentuk tubuh anda?						
7.	Apakah Anda pernah merasa khawatir tentang paha Anda yang tampak melebar saat sedang duduk?						
8.	Apakah makan walaupun sedikit pernah membuat anda merasa gemuk?						
9.	Apakah anda pernah menghindar untuk mengenakan pakaian yang membuat anda makin sadar akan bentuk tubuh anda?						
10.	Apakah makan permen, kue-kue, atau makanan berkalori tinggi lainnya pernah membuat anda merasa gemuk?						
11.	Apakah Anda pernah merasa malu dengan (bentuk) tubuh Anda?						
12.	Apakah rasa khawatir terhadap bentuk (tubuh) pernah membuat Anda (menjalani) diet?						
13.	Apakah Anda pernah merasa paling bahagia dengan bentuk (tubuh) Anda saat perut Anda belum terisi (contoh: di pagi hari)?						
14.	Pernahkah anda merasa bahwa tidak adil jika perempuan-perempuan lain lebih langsing daripada Anda?						

No.	Pertanyaan	6	5	4	3	2	1
15.	Pernahkah anda merasa khawatir badan anda akan banyak selulit?						
16.	Apakah kekhawatiran terhadap bentuk tubuh Anda pernah membuat Anda merasa harus berolahraga?						

Sumber : (Evans & Dolan, 1993)

Lampiran 5. Kuesioner Perilaku Makan

Kuesioner DEBQ (Dutch Eating Behaviour Questionnaire)

Petunjuk :

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menanyakan tentang perilaku makan anda Untuk setiap pertanyaan, harap (√) yang paling menggambarkan seberapa sering Anda merasakan hal ini.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		Tidak Pernah	**Jarang**	**Kadang-kadang**	**Sering**	**Selalu**
1.	Apakah kamu ingin makan ketika kamu kesal?					
2.	Ketika makanannya terasa enak, apakah kamu akan makan lebih banyak dari biasanya?					
3.	Keinginan untuk					

	makan, jika sedang tidak ada aktivitas apapun?					
4.	Ketika berat badan kamu bertambah, apakah kamu akan makan lebih sedikit dari biasanya?					
5.	Apakah kamu ingin makan ketika kamu merasa depresi atau sedih?					
6.	Ketika makanan terasa dan tercium enak, apakah kamu akan makan lebih banyak dari biasanya?					
7.	Seberapa sering kamu menolak makanan atau minuman karena khawatir dengan berat badan kamu?					
8.	Apakah kamu ingin makan ketika merasa kesepian?					
9.	Ketika kamu melihat atau					

	mencium sesuatu yang lezat, apakah kamu ingin memakannya?					
10.	Apakah kamu ingin makan ketika seseorang membuat kamu kecewa?					
11.	Di waktu makan, apakah kamu mencoba untuk makan lebih sedikit dari yang sebetulnya kamu inginkan?					
12.	Jika kamu punya makanan yang lezat, apakah kamu akan segera memakannya?					
13.	Apakah kamu ingin makan ketika seseorang membuat kamu marah?					
14.	Apakah kamu betul-betul memperhatikan (melihat) apa yang					

	kamu makan?					
15.	Ketika kamu sedang berjalan melewati toko makanan, apakah kamu merasa ingin membeli sesuatu yang enak?					
16.	Apakah kamu berkeiginan untuk tetap makan pada saat sedang tidak enak?					
17.	Apakah kamu dengan sengaja memakan makanan yang dapat					
18.	Ketika melihat orang lain makan, apakah Kamu juga merasa ingin makan ?					
19.	Ketika kamu makan banyak, apakah kamu makan lebih sedikit Di hari-hari berikutnya?					

20.	Apakah Kamu menjadi ingin makan ketika gelisah, khawatir, dan tegang?					
21.	Apakah Kamu merasa sulit menolak makanan yang lezat ?					
22.	Apakah Kamu dengan sengaja makan lebih sedikit karena tidak ingin bertambah berat badan?					
23.	Apakah Kamu merasa ingin makan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau berjalan tidak semestinya?					
24.	Ketika melewati toko atau warung makanan yang menyediakan makanan enak, apakah Kamu					

	ingin membelinya?					
25.	Apakah Kamu ingin makan ketika sedang emosi?					
26.	Apakah kamu pernah tidak makan karena sedang DIET ?					
27.	Apakah kamu ingin makan lebih banyak dari biasanya, ketika melihat orang lain makan?					
28.	Keinginan untuk makan karena sedang bosan?					
29.	Seberapa sering kamu menghindari makan malam karena kamu sedang menjaga berat badan?					
30.	Apakah kamu merasa ingin makan ketika merasa takut?					

31.	Apakah kamu mengaitkan berat badan kamu dengan apa yang kamu makan?					
32.	Apakah kamu ingin makan ketika kamu merasa kecewa?					
33.	Apakah kamu makan, pada saat sedang menyiapkan makanan?					

Sumber : (Van Strien et al. 1986)